

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA TUBERCULOSIS
INSTRUCTIVO DE DILIGENCIAMIENTO
LIBRO DE REGISTRO DE PERSONAS AFECTADAS POR TUBERCULOSIS SENSIBLE

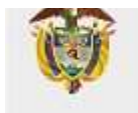
Versión 001.

El libro de personas afectadas por tuberculosis sensible es un instrumento que posibilita el registro nominalizado de usuarios confirmados con diagnóstico de tuberculosis a nivel bacteriológico y/o clínico, con o sin inicio de tratamiento. Esto permitirá la inclusión del 100% de usuarios confirmados por la enfermedad y tener una evaluación general del comportamiento programático del evento, para lo cual este registro incluye datos sociodemográficos como la edad, sexo, grupo poblacional, pertenencia étnica, tipo de ingreso si es un caso nuevo o previamente tratado, tipo de tuberculosis si es pulmonar o extrapulmonar, la configuración en el diagnóstico por prueba molecular, las comorbilidades, controles en el seguimiento y la evaluación de egreso en el tratamiento entre otras.

Este libro es responsabilidad en su diligenciamiento según el artículo 3 de la Resolución 227 de 2020, en los prestadores de servicios de salud público y privado, y todos aquellos quienes realicen diagnóstico o seguimiento durante el tratamiento. Se debe reportar y actualizar los datos por los prestadores que efectúen tanto el diagnóstico, como aquel que lleva el seguimiento en el tratamiento, información que deberá ser articulada en los diferentes niveles de gestión a nivel de la prestación de los servicios de salud, el aseguramiento y el seguimiento de las acciones de gestión en salud pública para su complementariedad en el nivel municipal, y de allí al departamental o distrital y su envío trimestral al nivel nacional.

A continuación, se describen las pautas para el adecuado diligenciamiento del libro de personas afectadas por TB, y los conceptos claves tomados de la Resolución 227 de 2020 que deben orientar su diligenciamiento, para lo cual los responsables de la generación de datos deben seguir las siguientes recomendaciones:

- ✓ Se realiza captura de datos mediante plantilla predeterminada en archivo Microsoft Excel, para lo cual se recomienda no alterar la estructura de la base de información y utilizar para el registro siempre los desplegables que permita generar los conteos automáticos de información.
- ✓ Se deben registrar el 100% de los casos diagnosticados por tuberculosis pulmonar y extrapulmonar confirmados por criterio microbiológico y/o clínico, con o sin inicio de tratamiento.
- ✓ En caso de diagnóstico inicial sin indicio de tratamiento y condición de ingreso vivo se deja perdida en el seguimiento en el egreso y se continúa seguimiento hasta que la persona ingrese a tratamiento.
- ✓ Se deben registrar los casos diagnosticados postmortem causa básica fallecimiento clasificación CIE 10 Tuberculosis.



- ✓ Su diligenciamiento es diario por los prestadores o Unidades Generadoras de Datos (UPGD), con evaluación de la cohorte mensual/trimestral, de 6 a 9 meses retrospectivo, según la fecha de inicio de tratamiento.
- ✓ El análisis de datos se debe realizar tomando como referencia datos como por ejemplo los casos nuevos y recaídas por lugar de residencia para el cálculo de la tasa general de incidencia.
- ✓ Se deben incluir en los análisis las variables de tipo de tuberculosis, casos de TB según edad y sexo, tipo de diagnóstico por pruebas realizadas, acciones colaborativas, comorbilidades, egreso al tratamiento.
- ✓ Si la persona reingresa varias veces al programa de TB durante el mismo año, se debe dejar el registro del último reingreso al tratamiento; este será el registro que se mantenga para evaluación de cierre en la cohorte.
- ✓ Si el paciente ingresa en años distintos, se debe realizar el cierre en el año anterior con la condición de egreso según corresponda.
- ✓ Realizar reingreso en el año correspondiente discriminando la categoría y definición de reingreso tras recaída o tras pérdida en el seguimiento o tras fracaso con la solicitud prioritaria de pruebas de sensibilidad a fármacos.
- ✓ Evitar copiar y pegar información de otras fuentes de información como SIVIGILA, ya que puede alterarse el conteo automático de casos.
- ✓ La información contenida en el libro de personas afectadas, deberá mantener criterios de calidad, veracidad, completitud de la información y es responsabilidad mantener custodia en el anonimato de datos de identificación en los diferentes niveles según los artículos 5 y capítulo 9 de la Resolución 227 de 2020 y leyes relacionadas con protección de datos personales.

DATOS GENERALES

Columna A. Número: Diligenciar el número consecutivo de diagnóstico del caso, 1,2,3,4.....

Columna B. Departamento de diagnóstico: Diligenciar el departamento de diagnóstico del caso de tuberculosis.

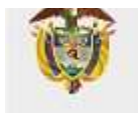
Columna C. Municipio de diagnóstico: Diligenciar el municipio de diagnóstico del caso de tuberculosis. La concordancia debe ser superior al 95% de los casos reportados en el SIVIGILA y en laboratorio de salud pública.

Columna D. IPS de diagnóstico: Diligenciar nombre del prestador que realizó el diagnóstico del caso de tuberculosis.

Columna E. IPS de seguimiento al tratamiento: Diligenciar el prestador donde actualmente está recibiendo el tratamiento el usuario.

Columna F. Trimestre del año: Seleccionar el trimestre según corresponda, tener en cuenta que el registro del trimestre concuerde con el mes de inicio de tratamiento:

- Primer trimestre (I), hace referencia a los meses de enero, febrero, y marzo.



- Segundo trimestre (II) hace referencia a los meses de abril, mayo y junio.
- Tercer trimestre (III) hace referencia a los meses de julio, agosto y septiembre.
- Cuarto trimestre (IV) hace referencia a los meses de octubre, noviembre, y diciembre.

Se debe tener en cuenta que la evaluación de egreso en el tratamiento y el registro de la base nominal de pacientes se realiza trimestralmente y de forma acumulativa, es decir, se ingresa anualmente y consecutivamente se presenta en la base todos los pacientes que correspondan al año desde el 01 enero hasta el 31 de diciembre. La actualización de casos se debe general diariamente por la IPS y generarse evaluación de cierre de tratamiento trimestralmente para su envío al nivel departamental y de allí a la nación.

Columna G. Fecha de Inicio de síntomas (dd/mm/aaaa). Diligenciar fecha de inicio de síntomas presuntivos en la persona que fue confirmada posteriormente con la TB, registrar día, mes y año de inicio en síntomas.

Columna H. Ingres a tratamiento: Seleccionar si el paciente ingresó o no al tratamiento de la tuberculosis. Si fué diagnosticado y la persona no reporta inicio de tratamiento se deja en egreso pérdida en el seguimiento al tratamiento, y debe reportar a la aseguradora y equipo de salud pública para su búsqueda y localización.

Columna I. Fecha de inicio de tratamiento (dd/mm/aaaa). Diligenciar fecha de ingreso a tratamiento del paciente, registrando día, mes y año donde recibe la primera toma en el tratamiento actual.

Columna J. Nombres: Diligenciar el primer nombre, como aparezca en el documento de identidad.

Columna K. Primer Apellido: Diligenciar el primer apellido, como aparezca en el documento de identidad.

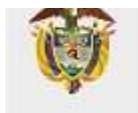
Columna L. Segundo Apellido: Diligenciar el segundo apellido, como aparezca en el documento de identidad.

Columna M. Sexo: Seleccionar el sexo, como aparezca en el documento de identidad.

Columna N. Edad en años: Seleccionar con el desplegable la edad del paciente. Si es un niño o niña con meses de nacimiento, se selecciona <1año, el consecutivo de edad se encuentra disponible en años entre 1 a 115 años.

Columna O. Tipo de identificación: Seleccionar en el desplegable según corresponda: CC: Cédula de ciudadanía. TI: Tarjeta de identidad. RC: Registro Civil. MS: Menor sin identificar. CE: Cédula de extranjería. PS: Pasaporte. PEP Permiso especial de permanencia. NIUP: Número único de identificación personal. AS: Adulto sin identificación. Número: Diligenciar el número de documento de la persona afectada por tuberculosis.

Columna P. Número ID: Diligenciar el número de documento de identidad, como aparezca en el documento de identificación del paciente. En caso de dudas se recomienda ingresar a la base BDUa comprobador de derechos para constatar nombres, lugar y aseguramiento: <https://www.adres.gov.co/consulte-su-eps>



Columna Q. Pertenencia étnica: Seleccionar la pertenencia étnica según corresponda: Indígena, afrodescendiente, rom, raizal o gitano.

Columna R. Pueblo indígena: Se la persona tiene pertenencia étnica como indígena se debe reportar el pueblo al cual pertenece. Si la persona NO es indígena, esta columna se deja en blanco.

Columna S. Grupo poblacional: Seleccionar del desplegable según corresponda: Persona con discapacidad, desplazado, migrante, población carcelaria, gestante, habitante de calle, población infantil a cargo del ICBF, madres comunitarias, desmovilizados, población en centros psiquiátricos, LGBTQ+, víctima de la violencia armada, trabajador de la salud, otros.

Columna T. Dirección de residencia: Diligenciar la dirección de la vivienda donde habita la persona afectada por tuberculosis, recordar diligenciar los complementos como conjunto residencial, torre y apartamento, camino, vereda, camino que permita la localización posterior en la vista domiciliaria.

Columna U. Teléfono del usuario: Diligenciar mínimo dos números telefónicos de la persona afectada por tuberculosis (el de la persona y el de familiar o de contacto dejado por el usuario).

Columna V. barrio de residencia: Diligenciar el barrio en áreas urbanas o en zonas rurales la vereda de la persona afectada por tuberculosis. Evitar abreviaturas. Diligenciar información que permita la ubicación del paciente, con datos señas o inclusive coordenadas para su geolocalización.

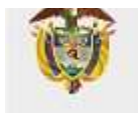
Columna W. Comuna / Localidad de Residencia. Diligenciar la comuna o localidad de residencia de la persona afectada por tuberculosis, o datos complementarios que permitan su ubicación, útil para el mapeo de casos y la georreferenciación.

Columna X. Régimen de afiliación: Seleccione en el desplegable el régimen al que pertenece el usuario, según corresponda: Contributivo, subsidiado, no asegurado, especial, excepción. (Realizar verificación BDUA <https://www.adres.gov.co/consulte-su-eps>)

Columna Y. EAPB: Seleccione en el desplegable la EAPB según corresponda. (Realizar verificación en el BDUA <https://www.adres.gov.co/consulte-su-eps>)

Columna Z. Tipo de tuberculosis: Seleccionar en el desplegable el tipo de tuberculosis, el cual hace referencia a la clasificación basada en la localización anatómica de la enfermedad, la cual se divide en dos:

- **Tuberculosis pulmonar:** se refiere a cualquier caso bacteriológicamente confirmado o clínicamente diagnosticado de tuberculosis, que afecta el parénquima pulmonar o el árbol laringo traqueobronquial. La tuberculosis laríngea y miliar se deben clasificar como tuberculosis pulmonar.
- **Tuberculosis extrapulmonar:** se refiere a cualquier caso bacteriológicamente confirmado o clínicamente diagnosticado de tuberculosis, que afecta otros órganos que no sean los pulmones, como, por ejemplo, la pleura, ganglios linfáticos, abdomen, tracto genitourinario, piel, articulaciones, huesos, y meninges. Las linfadenopatías tuberculosas intratorácicas (mediastinales o hiliares) o el derrame pleural causado por la tuberculosis sin alteraciones radiográficas de los pulmones, configuran un caso de tuberculosis extrapulmonar.



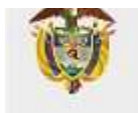
Columna A.A Localización de tuberculosis extrapulmonar: Seleccionar en el desplegable el tipo de tuberculosis extrapulmonar. Si el caso es de tuberculosis pulmonar, esta columna queda en blanco. Se debe seleccionar la opción del desplegable según el tipo de tuberculosis extrapulmonar:

- Meníngea
- Peritoneal
- Ganglionar
- Renal
- Intestinal
- Osteoarticular
- Genitourinaria
- Pericárdica
- Cutánea
- Pleural
- Otro (hace referencia a otro tipo de tuberculosis extrapulmonar que no se encuentre en el desplegable).

Si existe un tipo de tuberculosis pulmonar y afectación extrapulmonar en la persona, prima el registro de reporte de la forma pulmonar.

Columna AB. Condición de ingreso: Se seleccionar del desplegable la condición de ingreso que corresponda:

- **Caso nuevo:** aquel que nunca ha sido tratado por tuberculosis o que ha recibido medicamentos antituberculosos por menos de un mes.
- **Caso previamente tratado:** persona que ha recibido un mes o más de tratamiento con medicamentos antituberculosos en el pasado. Se clasifica además por el resultado de su más reciente ciclo de tratamiento de la siguiente manera:
 - ✓ **Reingreso tras recaída:** persona que ha sido previamente tratada por tuberculosis, fue declarada como curada o con tratamiento terminado al final de su último ciclo de tratamiento y ahora se le diagnostica con un episodio recurrente de tuberculosis (Ya sea una verdadera recaída o un nuevo episodio de tuberculosis causado por reinfección).
 - ✓ **Reingreso tras fracaso:** persona previamente tratada por tuberculosis, cuyo tratamiento fracasó, evidenciado mediante un resultado de baciloscopia o cultivo de esputo positivo en el cuarto mes, o posterior, durante el tratamiento.
 - ✓ **Reingreso tras pérdida en el seguimiento:** persona que había sido tratada previamente por tuberculosis y fue declarada como perdida en el seguimiento, realizado al final de su tratamiento más reciente y reingresa nuevamente al programa.
 - ✓ **Otros previamente tratados:** son aquellos que han sido previamente tratados por tuberculosis, pero cuyo resultado después del tratamiento más reciente es desconocido o no ha sido documentado.



- ✓ **Remitido:** Caso que ha sido remitido de otra entidad territorial para continuar con el tratamiento de tuberculosis o referenciado internacionalmente por el Centro Nacional de Enlace del Ministerio de Salud y Protección Social.

DIAGNÓSTICO DE LA TUBERCULOSIS: Hace referencia a los criterios diagnósticos y/o ayudas diagnósticas que permitieron la identificación del caso de tuberculosis.

Columna AC. Baciloscopia: Seleccionar del desplegable el resultado de la baciloscopia en caso en que esté disponible según carga bacilar: negativo, (1 a 9) BAAR,(+),(++),(+++), No realizado(NR). El 100% de los casos con diagnóstico de tuberculosis deben tener registro de resultados microbiológicos en la medida de lo posible.

Columna AD. Fecha: Diligenciar fecha de resultado de la baciloscopia, según lo reporta el laboratorio, diligenciando día/mes/año.

Columna AE. Cultivo Líquido: Seleccionar del desplegable el resultado de cultivo de diagnóstico: Negativo, (1 a 19) BAAR,(+),(++),(+++), No Realizado (NR), contaminado, en proceso. El 100% de los casos con diagnóstico de tuberculosis pulmonar deben tener registro de cultivo líquido. El 100% de los casos con diagnóstico de tuberculosis extrapulmonar deben tener reporte de cultivo líquido en muestras extrapulmonares según hayan sido procesadas o solicitadas coherente con información consignada en la tarjeta individual de tratamiento.

Columna AF. Fecha Resultado Cultivo Líquido: Diligenciar fecha de resultado del cultivo de diagnóstico día/mes/año, se puede registrar la fecha de la siembra o la fecha del reporte del cultivo y generar su actualización según los resultados disponibles.

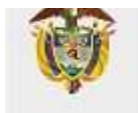
Columna AG. Prueba Molecular. Seleccionar del desplegable el resultado de la prueba molecular según el reporte de laboratorio: Detectado, No detectado, No interpretable, Contaminado. Recordar que se debe realizar las pruebas moleculares de acuerdo a los algoritmos diagnósticos mencionados en la Resolución 227 de 2020, empleando técnicas que cuenten con un alto nivel de sensibilidad y capacidad de detección del perfil de resistencia mínimo a rifampicina e isoniacida.

Columna AH. Fecha PM: Diligenciar fecha de resultado de la prueba molecular de diagnóstico día/mes/año.

COINFECCIÓN TB/VIH: Hace referencia a las actividades colaborativas tuberculosis y VIH

Columna AI. Se realizó APV o Asesoría para Prueba de VIH: Seleccionar del desplegable, SI se realizó asesoría para prueba de VIH, o si NO se realizó asesoría para prueba de VIH. Si el paciente no acepto la asesoría se selecciona PACIENTE NO ACEPTA. Si el paciente fue diagnosticado con VIH previo al diagnóstico de la tuberculosis se registra VIH + PREVIO. (Se considera VIH previo si el diagnóstico del VIH fue realizado 30 días anteriores al diagnóstico de la tuberculosis).

Columna AJ. Se realizó prueba. Seleccionar del desplegable, SI se realizó la prueba de VIH, o si NO se realizó prueba de VIH. Si el paciente no acepto la prueba se registra PACIENTE NO ACEPTA. Si el paciente fue diagnosticado con VIH previo al diagnóstico de la tuberculosis se registra VIH + PREVIO. (Se considera VIH previo si el diagnóstico del VIH fue realizado 30 días anteriores al



diagnóstico de la tuberculosis).

Columna AK. Resultado de Prueba. Resultado de la prueba Presuntiva del VIH: Seleccionar del desplegable el resultado de la prueba presuntiva del VIH, según el reporte de laboratorio como POSITIVO o NEGATIVO. Si el paciente no acepto la prueba se registra PTE NO ACEPTA. Si el paciente fue diagnosticado con VIH previo al diagnóstico de la tuberculosis se registra VIH + PREVIO. (Se considera VIH previo si el diagnóstico del VIH fue realizado 30 días anteriores al diagnóstico de la tuberculosis). Si no se tiene el registro se reporta No Reporta, recordando que el 100% de personas con TB se les debe descartar VIH.

Columna AL. Fecha de realización (dd/mm/aaaa). Diligenciar la fecha de la realización de la prueba presuntiva de VIH, en día/mes/año, según el reporte de laboratorio.

Columna AM. Resultado de Prueba Confirmatoria. Solo se diligencia si el resultado de la prueba presuntiva fue positiva o el paciente es VIH + Previo. (Si el resultado de la prueba confirmatoria fue negativa esta columna se deja en blanco). Seleccionar del desplegable el resultado de la prueba confirmatoria del VIH, según el reporte de laboratorio como POSITIVO o NEGATIVO. Si el paciente no acepto la prueba se registra PTE NO ACEPTA. Si el paciente fue diagnosticado con VIH previo al diagnóstico de la tuberculosis se registra VIH + PREVIO. (Se considera VIH previo si el diagnóstico del VIH fue realizado 30 días anteriores al diagnóstico de la tuberculosis). Se deben seguir los últimos algoritmos diagnósticos, para la atención del VIH en niños, adultos, gestantes entre otros grupos según las guías del Ministerio de Salud y Protección Social.

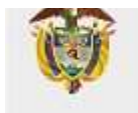
Columna AN. Fecha de realización: Diligenciar fecha de realización de la prueba confirmatoria o la fecha del diagnóstico previo de VIH o la fecha del diagnóstico actual del VIH. Se debe diligenciar día/mes/año.

Columna AO. Recibe TAR. Recibe Tratamiento Antirretroviral: Se debe seleccionar en el desplegable, siempre y cuando se confirme el resultado positivo de la prueba de VIH o el caso sea VIH + PREVIO, registrar SI, si recibe el tratamiento antirretroviral y NO si no lo recibe. (Si el resultado de la prueba presuntiva fue NEGATIVA, este campo quedara en blanco). Recordar que el 100% de las personas con TB y VIH deben tener inicio de ARV acorde al capítulo 6 de la Resolución 0227 de 2020.

Columna AP. Recibe Trimetoprim Sulfametoxazol: Se debe seleccionar del desplegable, siempre cuando se confirme el resultado positivo de la prueba de VIH o el caso sea VIH PREVIO, registrar SI, si recibe el tratamiento con Trimetoprim o TMS y NO si no lo recibe. (Si el resultado de la prueba presuntiva fue NEGATIVA, este campo quedara en blanco). Desde los programas de TB y atención primaria se indica que toda persona con TB y VIH debe recibir profilaxis, no obstante acorde al conteo de CD4 superior a 350 o valoración de medico experto definirá la pertinencia de continuar o suspender este tratamiento.

CONTROL BACTERIOLÓGICO

Columna AQ. BK (Final 1ª Fase): Seleccionar del desplegable el resultado de BK seriado de control de final de la primera fase, según lo reporta el laboratorio: Negativo, 1 a 9 BAAR, (+), (++), (+++), no realizado. El 100% de los casos con diagnóstico de tuberculosis pulmonar deben tener registro de



baciloscopia de control de final de primera fase. Es decir, a los dos meses de iniciado el tratamiento antituberculoso.

Si se evidencia un control positivo al segundo mes se configura una sospecha de fracaso y amerita de manera Urgente Solicitar Pruebas de Sensibilidad a Fármacos, Cultivo Líquido y valoración por médico tratante. En cuanto al tratamiento se prolonga la fase intensiva RHZE hasta obtener los resultados de las pruebas de sensibilidad, o negativización. Si es resistente se deja como fracaso en TB sensible y se inscribe al libro de TB farmacorresistente.

Columna AR. BK (Mitad 2ª Fase): Seleccionar del desplegable el resultado de BK seriado de control de mitad de la segunda fase, según lo reporta el laboratorio: Negativo, 1 a 9 BAAR, (+), (++) , (+++), No Realizado. El 100% de los casos con diagnóstico de tuberculosis pulmonar deben tener registro de baciloscopia de control de mitad de la segunda fase de tratamiento. Es decir, al cuarto mes de iniciado el tratamiento antituberculoso.

Columna AS. BK (Final de tratamiento): Seleccionar del desplegable el resultado de BK seriado de control de final de tratamiento, según lo reporta el laboratorio: Negativo, 1 a 9 BAAR, (+), (++) , (+++), , No Realizado. El 100% de los casos con diagnóstico de tuberculosis pulmonar deben tener registro de baciloscopia de control de final de tratamiento. Es decir, al sexto mes de iniciado el tratamiento antituberculoso.

Columna AT. Cultivo al final del tratamiento: Seleccionar del desplegable el resultado de cultivo de final del tratamiento: Negativo, 1 a 9 BAAR, (+), (++) , (+++), Contaminado, No Realizado (NR). Los casos diagnosticados con cultivo, se les debe registrar el reporte de cultivo de finalización de tratamiento.

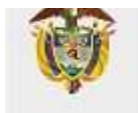
RECOMENDACIONES PARA CONTROLES DE TRATAMIENTO

- Los casos que sean diagnosticados por Prueba Molecular recordar que el control bacteriológico al tratamiento se realiza con baciloscopia, esto dado a que si se realiza prueba molecular fragmentos de ADN pueden ser detectados sin que estos sean viables.
- Cuando el diagnóstico es por cultivo líquido los controles deben realizarse por cultivo líquido.
- Cuando es un diagnóstico de tuberculosis extrapulmonar no requiere controles bacteriológicos dado a que el seguimiento es netamente clínico, y/o radiológico.
- Para los controles bacteriológicos se debe procesar UNA sola muestra para labaciloscopia.
- Si la Baciloscopia de control sale positiva debe realizarse Prueba Molecular que incluya sensibilidad a fármacos y cultivo líquido.

SENSIBILIDAD A FÁRMACOS

Columna AU. Prueba de susceptibilidad a fármacos. Seleccionar del desplegable el tipo de prueba de susceptibilidad a fármacos antituberculosos realizada, dentro de las opciones disponibles están:

- NITRATO REDUCTASA



- PROPORCIONES EN LJ
- BACTEC MGIT
- PROPORCIONES EN AGAR
- LIPA (Genotype, Anyplex)
- PCR EN T' REAL (Genexpert)
- NO REALIZADA

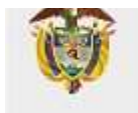
Columna AV. Tipo de farmacoresistencia. Seleccionar del desplegable el tipo de farmacoresistencia presentada en el reporte de la prueba de sensibilidad:

- **Monorresistencia:** resistencia a sólo un medicamento antituberculosis de primera línea (Rifampicina (R), Isoniazida (H), Pirazinamida (Z), Estreptomina (S), Etambutol (E).
- **Polirresistencia:** resistencia a más de un medicamento antituberculosis de primera línea (que no sea isoniacida y rifampicina a la vez).
- **MDR (Multidrogoresistencia):** resistencia in vitro a isoniacida y rifampicina simultáneamente o combinada con otros fármacos antituberculosis.
- **RR:** resistencia in vitro solo a rifampicina.
- **PREXDR (Pre extensamente resistente):** Seleccione cuando exista un caso con multidrogoresistencia, que es resistente a una fluoroquinolona o al menos a uno de los medicamentos del grupo A existentes en la Resolución 0227 de 2020, tales como bedaquilina, linezolid.
- **XDR (Extensamente resistente):** es un caso con multidrogoresistencia, que es resistente a una fluoroquinolona y al menos a uno de los medicamentos del Grupo A existentes en la Resolución 0227 de 2020, tales como bedaquilina, linezolid.

CONDICIÓN DE EGRESO

Columna AW. Condición de egreso: Hace referencia al resultado del tratamiento de las personas afectadas por tuberculosis sensible.

- **Curado:** Persona afectada por tuberculosis pulmonar con bacteriología confirmada al inicio del tratamiento y que tiene baciloscopia o cultivo negativo en el último mes de tratamiento y al menos en una ocasión anterior por lo menos con un mes de diferencia.
- **Tratamiento Terminado:** Persona afectada por tuberculosis que completó el tratamiento, sin evidencia de fracaso, pero, sin constancia que demuestre que la baciloscopia o el cultivo de esputo del último mes de tratamiento y al menos en una ocasión anterior, fueron negativos, ya sea porque las pruebas no se hicieron o porque los resultados no están disponibles.
- **Fracaso:** Persona afectada por tuberculosis cuya baciloscopia o cultivo de esputo es positivo en el cuarto mes o posterior durante el tratamiento.
- **Pérdida de Seguimiento:** Persona afectada por tuberculosis que no inició tratamiento o interrumpió el tratamiento durante un mes o más.



- **Fallecido:** Persona afectada por tuberculosis, que muere por cualquier razón antes de comenzar el tratamiento o durante su curso.
- **No Evaluado:** Persona afectada por tuberculosis a quien no se le ha asignado un resultado de tratamiento. Incluye los casos transferidos a otras IPS (Sin seguimiento) y también los casos cuyo resultado de tratamiento es desconocido por la IPS que reporta el dato.
- **Descartado:** Se refiere a persona diagnosticada con tuberculosis, que posteriormente de acuerdo a los resultados de los laboratorios clínicos, o por criterio del médico tratante se descarta la presencia del *Mycobacterium tuberculosis*. (Estos casos deben excluirse del análisis de los indicadores o de las cohortes, su reporte de casos en base se da en términos de trazabilidad en el sistema de información, cruces de datos y gestión de fármacos).

Columna AX. Fecha de egreso: Registrar fecha de egreso del tratamiento dd/mm/aa. Si el caso es fallecido se registra la fecha de fallecimiento generado en el certificado de defunción de las estadísticas vitales. Si el caso es pérdida en el seguimiento se registra la fecha de pérdida que corresponde a los 30 días posteriores al dejar de tomar el tratamiento el paciente. Si es caso es curado la fecha de egreso es la consulta médica de cierre. Si es tratamiento terminado la fecha de egreso será la fecha de la última dosis registrada y/o fecha de egreso de la consulta médica de cierre.

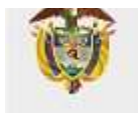
COMORBILIDADES

Columna AY. Comorbilidad 1. Seleccionar del desplegable la primera comorbilidad asociada a la persona afectada por tuberculosis, las cuales se deben tener en cuenta para el manejo del tratamiento antituberculoso. Si el paciente no tiene comorbilidades seleccionar la opción **Ninguna**. Dentro de las comorbilidades de mayor relevancia se encuentran:

- Alcoholismo
- Cáncer
- Consumo SPA
- Desnutrición
- Diabetes Mellitus
- Enfermedad autoinmune
- Enfermedad hepática
- Enfermedad Renal Crónica
- EPOC
- Ninguna
- Silicosis
- Tabaquismo
- VIH/SIDA
- COVID-19

Si existen otra comorbilidad no listada anteriormente se deja en casilla de observaciones.

Columna AZ. Comorbilidad 2. Seleccionas del desplegable la segunda comorbilidad asociada a la

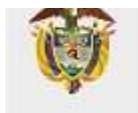


persona afectada por tuberculosis, las cuales se deben tener en cuenta para el manejo del tratamiento antituberculosos. Si el paciente no tiene comorbilidades seleccionar la opción **Ninguna**.

- Alcoholismo
- Cáncer
- Consumo SPA
- Desnutrición
- Diabetes Mellitus
- Enfermedad autoinmune
- Enfermedad hepática
- Enfermedad Renal Crónica
- EPOC
- Ninguna
- Silicosis
- Tabaquismo
- VIH/SIDA
- COVID-19
- Si existen otra comorbilidad no listada anteriormente se deja en casilla de observaciones.

Columna BA. Comorbilidad 3. Seleccionas del desplegable la tercera comorbilidad asociada a la persona afectada por tuberculosis, las cuales se deben tener en cuenta para el manejo del tratamiento antituberculoso. Si el paciente no tiene comorbilidades seleccionar la opción **Ninguna**.

- Alcoholismo
- Cáncer
- Consumo SPA
- Desnutrición
- Diabetes Mellitus
- Enfermedad autoinmune
- Enfermedad hepática
- Enfermedad Renal Crónica
- EPOC
- Ninguna
- Silicosis
- Tabaquismo
- VIH/SIDA
- COVID-19
- Si existen otra comorbilidad no listada anteriormente se deja en casilla de observaciones.

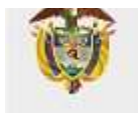


Columna BB. Departamento de residencia: Diligenciar el departamento donde reside del caso de tuberculosis.

Columna BC. Municipio de residencia: Diligenciar el municipio donde reside el caso del caso de tuberculosis.

Columna BD. Modalidad de tratamiento directamente observado. Seleccionar del desplegable el tipo de TDO en el que se le está administrando el tratamiento al paciente.

- **TDO en IPS:** Esta actividad implica la asistencia diaria de la persona a la IPS más cercada a su domicilio o trabajo, para recibir el tratamiento supervisado en boca. Se podrá realizar en cualquier institución básica o complementaria del país sin restricciones por tipo de aseguramiento. La administración estará a cargo del personal capacitado por ejemplo (medico, enfermero profesional, auxiliar de enfermería). Se llevará registro de dosis en la ficha individual de tratamiento y adecuada vigilancia de reacciones adversas acorde a lo dispuesto en el Programa Nacional de Tuberculosis (PNT).
- **TDO Domiciliario:** La respectiva EAPB, acorde a indicación del médico tratante, deberá autorizar la atención domiciliaria para la administración del TDO, en personas que por su condición clínica, social y económica, no les sea posible acudir a la IPS más cercana, por ejemplo, en el caso de personas con enfermedades crónicas y degenerativas, con limitaciones visuales o motoras, drogodependientes, oxígeno requirentes, con enfermedades mentales, adultos mayores, con ausencia de red familiar de apoyo, usuarios que requieren aplicación de inyectables, entre otros. Las EAPB deberán generar la atención requerida durante el tiempo que dure el tratamiento de manera interrumpida. La IPS de atención domiciliaria llevaran el registro correspondiente de dosis administradas en la ficha individual de tratamiento dispuesto por el PNT.
- **TDO Comunitario:** La entidad territorial deberá generar capacidades en líderes comunitarios, docentes, profesionales de otras instituciones del estado, organizaciones religiosas, centros de protección adulto mayor, centro de cuidado habitante de calle entre otros, para el desarrollo de actividades de apoyo a la supervisión y administración del tratamiento supervisado, coordinado con las IPS y EAPB. Las entidades territoriales, en el marco de los procesos de caracterización social, propios de la gestión de la salud pública y fortalecimiento de capacidades, deberán realizar el mapeo de los actores, agentes comunitarios y sociales, presentes en su territorio. El gestor o líder comunitario será debidamente entrenado para llevar el registro de dosis administradas, en la ficha individual de tratamiento, dispuesta por el PNT, con el acompañamiento del equipo de salud.
- **TDO Hospitalario:** Esta modalidad aplica en persona con diagnóstico de tuberculosis, TB/VIH, tuberculosis farmacorresistente, que, por su condición clínica, social o a juicio del médico tratante, requieran hospitalización temporal, para el monitoreo de reacciones adversas graves o el seguimiento ante comorbilidades crónicas del tipo renal, hepático o metabólico, que



puedan derivar complicaciones. En el caso de personas en situación de habitante de calle que hayan sido hospitalizadas, las IPS deberán, previo al egreso hospitalario, realizar articulación con centro de autocuidado y protección de habitante de calle para asegurar la continuidad del tratamiento supervisado.

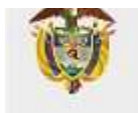
- **TDO virtual:** Las EAPB, a través de sus prestadores de servicios de salud, en articulación con la entidad territorial, deberán evaluar la pertinencia de inclusión de herramientas tecnológicas de supervisión del tratamiento tales como: videoconferencias, videollamadas o registro en video diario de tratamiento. La administración del TDO virtual será acompañada por mensajes de texto y seguimiento telefónico que recuerde la toma de la medicación, previa concertación individual con la persona afectada o su cuidador. Esta modalidad deberá contar con la firma de consentimiento informado donde se explique las pautas de administración y registro del TDO y ser aplicadas según el contexto social y de acceso las tecnologías disponibles en cada usuario.

Columna BE. Tipo de programas de protección social que recibe. Seleccionar del desplegable el tipo de programas de protección social que recibe el paciente con tuberculosis. Si el paciente NO recibe ningún tipo de subsidios seleccionar la opción: No aplica a subsidios

- Subsidio alimentario
- Subsidio de vivienda
- Subsidio de desempleo
- Subsidio educativo
- Subsidio monetario
- Cuenta con varios subsidios de apoyo
- No aplica a subsidios

Columna BF. Reacciones adversas al tratamiento. Seleccionar del desplegable si el paciente presenta reacciones adversas al tratamiento. Si el paciente NO ha presentado reacciones adversas, seleccionar: Ninguna.

- **Leve:** No es necesario ningún antídoto ni tratamiento; hospitalización breve.
- **Moderado:** Es precisa una modificación del tratamiento (p. ej., modificación de la dosis, adición de otro fármaco), pero la interrupción de la administración del fármaco no es imprescindible; puede ser necesario prolongar la internación o instaurar un tratamiento específico.
- **Grave:** La reacción adversa a fármacos pone en peligro la vida del paciente y exige interrumpir la administración del fármaco e instaurar un tratamiento específico.
- **Ninguna:** El paciente no ha presentado ninguna reacción adversa al tratamiento.



Columna BG. Metodología de captación del caso. Seleccionar del desplegable la metodología por el cual se captó el caso de tuberculosis.

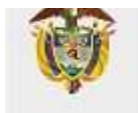
- Búsqueda activa institucional
- Búsqueda activa derivado de agente comunitario
- Búsqueda activa derivado de trabajador de la salud.
- Remitido por el Centro Nacional de Enlace
- Durante estudio de contactos

Columna BH. Nombre de la persona responsable de la administración del tratamiento. Diligenciar el nombre de la persona que se encuentra responsable de la administración del tratamiento en la IPS de supervisión del tratamiento.

Columna BI. Teléfono y correo electrónico de la persona responsable de la administración de tratamiento. Diligenciar el número de teléfono y correo electrónico de la persona que se encuentra responsable de la administración del tratamiento en la IPS de supervisión del tratamiento.

Columna BJ. Observaciones. Diligenciar las observaciones relacionadas con el paciente de tuberculosis.

Columna Bk: Zona geográfica urbana, rural o rural dispersa.



Aspectos claves a tener en cuenta.

- ✓ Todas las instituciones prestadoras de servicios de salud acorde al capítulo 5 de la Resolución 227 de 2020 están obligadas a reportar la información nominal de casos a los niveles municipales, y estos al nivel departamental, distrital y estos al nacional.
- ✓ Se debe llevar el libro registro de casos en todas las instituciones que confirmen casos, tanto en el nivel de complejidad básico y complementario.
- ✓ Se debe registrar el libro verificando las definiciones existentes en el capítulo 2 de la Resolución 227 de 2020, en su completitud, veracidad, oportunidad y calidad en el reporte de datos.
- ✓ Se debe incluir en el registro de información todas las personas con diagnóstico de tuberculosis, que reciben supervisión al TDO por agentes comunitarios y generar su respectiva identificación.

Nota: Todas las instituciones prestadoras de servicios de salud acorde al capítulo 5 de la Resolución 227 de 2020 están obligadas al reporte de la información, por ende, deben contar carpeta digital con los soportes del caso los cuales pertenecerán al registro de historia clínica en los siguientes archivos:

1. Ficha de notificación de tuberculosis evento 813.
2. Copia de historia clínica donde se consignen los resultados diagnósticos y de seguimiento más relevantes.
3. Reporte de laboratorios de diagnóstico.
4. Formula médica de primera y/o segunda fase.
5. Reporte de laboratorios de control bacteriológico.
6. Copia de la tarjeta de tratamiento con dosis actualizada a la fecha de administración.